**Ministério do Planejamento e Orçamento**
**Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID**
**Secretaria Executiva da COFIEX**
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

# CARTA CONSULTA

## Programa de Reestruturação e Qualificação da Rede Hospitalar e de Atenção Especializada da Cidade de São Paulo - Avança Saúde II

**Nº Carta Consulta: 60999**
**Processo: 03101.101831/2023-52**
**Mutuário: Município de São Paulo - SP**
**Tipo de Operação: Operação de crédito externo**
**Data de Recebimento: 14 de Junho de 2023**

**Fontes Internas:**
Contrapartida Financeira: US$ 205.300.000,00
**Fontes Externas:**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 205.300.000,00

# Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA ..... 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO ..... 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE ..... 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO ..... 04
2. PROJETO ..... 05
2.1. TÍTULO ..... 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO ..... 05
2.3. MUTUÁRIO ..... 05
2.4. TIPO OPERACAO ..... 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 05
2.6. PROJETO/INDICADORES ..... 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES ..... 08
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS ..... 10
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA ..... 12
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO ..... 12
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO ..... 13
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO ..... 15
3. FINANCIAMENTO ..... 15
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE ..... 15
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS ..... 15
4. EXECUÇÃO ..... 15
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL ..... 15
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES ..... 16
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO ..... 16
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA ..... 16
5. RISCOS ..... 18
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS ..... 18
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES ..... 18
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES ..... 18
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS ..... 18
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL ..... 18
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS ..... 18
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN ..... 18

# 1. Marco de Referência

## 1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO

O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

O Município de São Paulo (MSP), capital do estado de mesmo nome, é a cidade mais populosa do Brasil, do continente americano e de todo o hemisfério sul, com população projetada para 2020 de 11.869.660 habitantes (SEADE, 2020) e densidade demográfica de 7.803 hab/km2.

A pirâmide populacional do MSP (Gráfico 1 - Anexo 1) demonstra a concentração de adultos na faixa etária entre 20 e 59 anos de idade, já as pessoas com mais de 60 anos de idade já representam 15,6% da população (SEADE, 2020). Tal processo de envelhecimento populacional impacta diretamente na definição da agenda de políticas públicas no setor saúde, amplia a demanda por ações de cuidado relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), agravadas pelas comorbidades.

Em termos gerais, a redução da natalidade acompanhada da diminuição nas taxas de mortalidade vem gerando um envelhecimento populacional crescente no MSP.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

O Município de São Paulo apresenta algumas das características típicas de uma metrópole: alta densidade populacional, enormes desigualdades intrarregionais e envelhecimento crescente.

Administrativamente, o MSP é dividido em seis regiões de saúde marcadamente desiguais: Centro, Leste, Norte, Oeste, Sudeste e Sul. As diferenças epidemiológicas são marcantes entre as regiões, a expectativa de vida ao nascer, por exemplo, difere substancialmente entre os bairros da cidade. No Alto de Pinheiros, na Zona Oeste, a expectativa de vida ao nascer é de 85,33 anos. Já em São Miguel Paulista, na Zona Leste, esse valor cai para 71,28 anos (SMDHC, 2020).

O perfil de morbimortalidade de São Paulo também reflete as fortes disparidades socioeconômicas e históricas entre as regiões. Enquanto em algumas áreas da cidade as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são as condições de saúde prevalentes, em outras ainda persiste um quadro de doenças infecciosas e mortalidade materno-infantil que revela defasagens comuns em países em desenvolvimento. Por exemplo, a taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório chega a 27,78 em Campo Belo -região sul de SP- enquanto é 9, 34 em Anhanguera -região norte. Ao contrário, a Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) é de 8,24 em Campo Belo e 15,14 em Anhanguera ( 2015, SINASC/SMS).

As Tabelas 1 (Anexo 2) mostram as internações hospitalares ocorridas em estabelecimentos de saúde da Rede SUS sob gestão municipal (SMS) e estadual (SES), em 2021, segundo diagnóstico principal (Capítulo da CID 10). Observa-se o impacto da COVID que ampliou significativamente as internações relacionadas ao diagnóstico "algumas doenças infecciosas e parasitárias", porém ainda há predominância de internações relacionadas às DCNT.

Em relação ao perfil de mortalidade, são apresentados na Tabela 2 (Anexo 3) os coeficientes de mortalidade infantil e geral em 2021, além de taxas específicas. Observa-se que coeficiente de mortalidade infantil (CMI) vem mantendo tendência de queda nas duas últimas décadas no MSP, atingindo 10,3 óbitos/1.000 nascidos vivos em 2021.

REDE FÍSICA

A municipalidade possui uma rede de saúde complexa, potente e densidades tecnológicas diversificadas. Por outro lado, evidencia-se a presença significante do setor suplementar de saúde, girando em torno de 35% de beneficiários. O município conta com 72,7% da população coberta pela Atenção Primária (APS) à Saúde e 46,7% da população residente em área de atuação da Estratégia Saúde da Família (ESF). Reforça que um dos grandes desafios é consolidar a ESF como porta de entrada para o sistema, com metas para ampliar a cobertura no município.

No que diz respeito ao setor público, a cidade produz o maior número de procedimentos ambulatoriais de baixa, média e alta complexidades, assim como o maior número de internações SUS do país. Apresenta 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 24 hospitais gerais ou especializados que fazem parte de uma rede com 1.012 estabelecimentos / serviços de saúde sob gestão municipal, como detalhado na Tabela 3 (Anexo 4).

Na rede municipal os hospitais-dia atendem as cirurgias eletivas mais simples e as Unidade de Pronto Atendimento (UPA) as urgências mais simples, os hospitais municipais estão voltados para procedimentos urgentes, não tendo capacidade de atender as cirurgias eletivas mais complexas. Desta forma, cirurgias que poderiam ser antecipadas, em um caso mais simples, passa a ser atendida apenas quando o caso se agrava.

Não há diferenciação da rede hospitalar em hospitais estruturantes, estratégicos e de apoio, de acordo com os níveis de complexidade, levando, em muitos casos, à ocupação de leitos de alta complexidade com perfis patológicos não correspondentes a essa densidade tecnológica.

Os hospitais municipais são antigos, necessitando de investimentos para adequação às normas sanitárias (RDC Nº 51, DE 6 DE OUTUBRO DE 2011) e de mobilidade (ABNT-NBR-9050 de 2020), além de atualização/modernização de seus equipamentos.

IDH

O IDH 0,805 em 2010.

**1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE**

SOLUÇÃO PROPOSTA

No seu esforço em sanar as principais inadequações do sistema de saúde da cidade, a SMS/SP aponta diversas questões a serem enfrentadas e superadas, em consonância com as metas da Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar (Plano Municipal de Saúde 2022-225).

O processo de planejamento e execução das políticas de saúde será mais efetiva quando (i) a reestruturação estiver consolidada; (ii) os sistemas de informação possibilitarem a troca de informações; (iii) a rede física existente estiver qualificada/modernizada e (iv) a equipe da SMS estiver qualificada para enfrentar os desafios que estão em constante transformação.

Neste sentido, em consonância com o Plano Municipal de Saúde 2022-2025, a requalificação física dos hospitais municipais é uma das prioridades e será apresentada no projeto como uma das propostas. Dos 24 hospitais municipais, há necessidade de intervenção em 13 hospitais para sua requalificação física. A viabilização da reforma estruturante seguirá diferentes estratégias:

a)Hospitais com projetos elaborados serão licitados com recurso de contrapartida anteriormente à assinatura do contrato de empréstimo: Sorocabana, Hungria, Alípio, Waldomiro de Paula e Saboya.

b)Hospitais com projetos a serem contratados: Campo Limpo; Tatuapé, Ignacio Proença, Tide Setúbal e Cachoeirinha.

c)Hospitais com estudos para Parceria Público Privada (PPP) incluindo CAPEX para reformar os hospitais: Zaio, Mario Degni e Benedicto.

Está prevista no Programa a aquisição de equipamentos para modernizar esses hospitais.

A reestruturação da Secretaria de Saúde foi iniciada com o decreto nº 59.685, de 13 de agosto de 2020. Neste período foram reestabelecidos fluxos e processos de trabalho e redefinidas atribuições, competências e responsabilidades. O desafio neste momento é consolidar e aprimorar os processos por meio de certificação de qualidade dos hospitais e dos laboratórios municipais. Será contratado uma empresa certificadora que atestará com base em evidencias que os hospitais e laboratórios atendem a determinados requisitos com relação aos seus processos, práticas, produtos e serviços. Esses requisitos são parâmetros previamente definidos e reconhecidos mundialmente como importantes para controle e aprimoramento da qualidade

No Programa Avança Saúde I foi investido no sistema de logística de suprimentos dos estoques centralizados até as unidades de saúde. A próxima etapa da gestão da logística é implantar o sistema informatizado de logística intra-hospitalar.

Para efetivar as ações propostas do Programa faz-se necessária a capacitação da equipe para a implantação do sistema e certificação de qualidade.

Nesse sentido, torna-se prioritário o investimento na melhoria estrutural (física e equipamentos) e qualificação tecno-assistencial dos pontos de atenção da hospitalar na cidade de São Paulo colocando a inovação em saúde como premissa para implementação de qualquer projeto.

RESULTADOS ESPERADOS

Em anexo está planilha em Excel que relaciona os resultados, descritos neste item aos indicadores (de "A" a "I"). Neste arquivo Excel também estão detalhados os indicadores e as metas anuais para cada um deles.

Dentre os resultados esperados, com relação a requalificação dos hospitais (obras, equipamentos, adequação estrutura física às normas sanitárias) espera-se a ampliação e modernização da quantidade de leitos, ambulatórios ou salas de procedimentos preparando a gestão municipal para atender a demanda epidemiológica atual e sua integração com a rede existente. Esses resultados estão associados aos indicadores A, E e G.

A Parceria Público Privado, além dos benefícios acima trará agilidade no processo de construção com possibilidade de redução do custo total ao longo da vida do ativo. Há de destacar as possibilidades de soluções inovadoras pelo ator privado, a otimização dos serviços com a partilha dos riscos entre setor privado e público. Esses resultados estão associados aos indicadores I, A, E e G.

Com relação a certificação de qualidade espera-se melhorar a qualidade da assistência prestada aos usuários do sistema de saúde, garantindo maior segurança para pacientes e profissionais de saúde tornando os processos de trabalho mais eficientes com melhor integração entre setores. Esses resultados estão associados ao indicador C.

O sistema informatizado de gestão de suprimentos intra-hospitalar deverá gerar padronização e ganho de eficiência no fluxo de distribuição de insumos no hospital, redução de custos e aumento da segurança do paciente. Esses resultados estão associados aos indicadores A,B,C, D,E e F.

A capacitação da equipe da SMS-SP aperfeiçoará os processos de trabalho dos profissionais que atuam no SUS com ações de Educação Permanente, visando contribuir com a melhoria da qualidade da atenção à saúde dos usuários, alcançando melhores resultados de saúde e maior satisfação dos pacientes. No programa estão previstas ações para capacitar profissionais da SMS para operacionalização do sistema de suprimentos intra-hospitalar e implantação dos processos de qualidade, resultado associado ao indicador I.

Resultado geral: Ampliar oferta e a qualidade do serviço hospitalar, com atendimento mais adequado às condições epidemiológicas e à rede de atenção municipal. Em termos de resultado destaca-se a melhoria da experiência do paciente, a adequação/otimização dos custos e o aumento da qualidade assistencial. Os resultados gerais (de impacto) são medidos pelos indicadores A, B, D, E e F.

SUSTENTABILIDADE

Vale destacar que a requalificação dos hospitais, não trará significativa ampliação dos custos de operação. Haverá uma ampliação dos serviços prestados por estes hospitais, que resultará em ampliação dos gastos com material de consumo, porém o custo de pessoal será suprido com realocação da equipe dos 3 hospitais objeto de PPP.

Portanto, o custo significativo para sustentabilidade financeira das ações do Programa se refere à remuneração dos gastos operacionais dos 3 hospitais, que deverá gerar economia em relação à operação atual ao otimizar os gastos com serviços de "bata cinza".

No anexo 11 estão apresentados os valores do incremento de custeio e manutenção referente as ampliações dos 13 hospitais atendidos pelo Programa. Comparado com as despesas da área Hospitalar (PPA 22-25 - anexo 10), o valor adicional não representa percentual tão significativo.

Verifica-se ainda que o incremento das despesas não ocupa percentual muito elevado do crescimento esperado da RCL (Anexo 12).

**1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO**

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

Como orientação estratégica prioritária, vale destacar as diretrizes e metas apresentadas no Plano Municipal de Saúde 2022-2025. O Avança Saúde II visa contribuir para alcance das metas e objetivos detalhadas no plano, visando garantir a atenção integral à saúde da população e o aprimoramento do acesso à saúde com fortalecimento das redes de atenção à saúde. Principalmente nas diretrizes relacionadas ao aumento a melhora da capacidade de gestão da SMS-SP; a reorganização dos serviços em redes de saúde integradas, com compartilhamento do cuidado entre os níveis de atenção; a organização da rede hospitalar, considerando as necessidades territoriais e a economia de escala; a integração e expansão dos sistemas de informação em saúde - melhorando a gestão clínica e gerencial, otimizando recursos e ampliando a qualidade dos dados.

No Plano Plurianual (PPA) 2022-2025, a principal ação vinculada ao Programa em pleito está a ação 3026 - AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE EM ATENÇÃO HOSPITALAR E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. Considerando a Agenda 2030, para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, essa ação está vinculado ao Objetivo 3/Meta 3.8: Atingir a cobertura universal de saúde, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes e de qualidade. O PPA prevê recursos para implantação de novos equipamentos e também para reforma, conforme sinalizado no recurso de contrapartida previsto no projeto.

O sistema previsto no Programa está vinculado à ação 3011 - MODERNIZAÇÃO, DESBUROCRATIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO SERVIÇO PÚBLICO e a capacitação está vinculada à ação 3024 - SUPORTE ADMINISTRATIVO.

Na Agenda 2030 (ONU), essas ações estão vinculadas aos objetivos e metas detalhadas abaixo:

-Objetivo 12: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

--Meta 12.7. Promover práticas de contratações e gestão pública com base em critérios de sustentabilidade, de acordo com as políticas e prioridades municipais.

-Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

--Meta 16.6. Ampliar a transparência, a prestação de contas, a efetividade e a eficiência das instituições, em todos os níveis.

-Objetivo 17: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

--Meta 17.17. Incentivar e promover parcerias eficazes nos âmbitos públicos, público-privados, privados e da sociedade civil, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

CONTRAPARTIDA

A contrapartida para o Programa será proveniente de receitas tributárias do município. Já há recurso disponível para contratação de obras de reforma para 6 hospitais que serão realizadas integralmente com recurso de contrapartida.

TAXA DE CÂMBIO

R$ 5,0589 (24/04/23)

## 2. Projeto

**2.1. Título**
Programa de Reestruturação e Qualificação da Rede Hospitalar e de Atenção Especializada da Cidade de São Paulo - Avança Saúde II

**2.2. Título Abreviado**
Avança Saúde II

**2.3. Mutuário**
Município de São Paulo - SP

**2.4. Tipo Operacao**
Operação de crédito externo

**2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS**
OBJETIVO GERAL

O objetivo do Programa é contribuir para a melhorar as condições de saúde da população do Município de São Paulo, por meio da ampliação do acesso, da qualidade dos serviços ofertados, da garantia de segurança do paciente e da melhoria do desempenho dos processos da rede hospitalar municipal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A.Adequar à legislação e ampliar a infraestrutura física da Rede Hospitalar Municipal.

B.Ampliar e modernizar o atendimento de hospitais municipal.

C.Certificar a qualidade de 24 hospitais e 6 laboratórios municipais.

D.Melhorar a eficiência e segurança na logística dos medicamentos e insumos intra-hospitalar

E.Capacitar profissionais da SMS para operacionalização do sistema de suprimentos intra-hospitalar e implantação dos processos de qualidade

O alinhamento dos objetivos resultados e indicadores encontra-se no anexo 8.2

**2.6. Projeto/Indicadores**

| Descrição | Fórmula de Cálculo | Unidade de Medida | Linha de Base | Meta |
|---|---|---|---|---|
| Número de cirurgia eletivas por mês | Numerador: Contagem absoluta de AIH, com procedimento realizado do grupo 04 .xx.xx.xxx-xx, excetuando os procedimentos obstétricos (04.11.xx. xxx-xx) Denominador: número de meses considerados * Hospitais considerados: 13 hospitais do Programa | cirurgias/mês | 789,50 | 950,00 |
| Tempo médio de Internação | Numerador: soma de Dias de Perm de todas as AIH do período considerado Denominador: contagem de AIH no período considerado ( todas as AIH) * Hospitais considerados: 13 hospitais do Programa | dias/AIH | 6,18 | 5,00 |
| Percentual de hospitais e laboratórios com certificação hospitalar | Numerador: Número de hospitais e laboratórios certificados no âmbito do programa financiado com recursos de empréstimo Denominador: Número de hospitais e laboratórios existentes | percentual | 0,00 | 100,00 |
| Taxa de Mortalidade Institucional | Numerador: contagem de AIH com motivo de cobrança óbito Denominador: contagem de AIH ( todas as formas de saída no período considerado) * Hospitais considerados: 13 hospitais do Programa | percentual | 5,50 | 4,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Número cirurgias por sala cirúrgica por dia | Numerador: quantidade total de saidas de AIH com procedimento cirurgico (excetuando obstetrícia 04.11.xx. xxx-xx) realizadas no mês Denominador: quantidade de salas cirurgicas-dia no mês (salas cirúrgicas CNES) * Hospitais considerados: 13 hospitais do Programa ** Salas consideradas: Sala de Cirurgia, Sala Cirurgia Ambulatorial | cirurgias/sala-dia | 2,00 | 2,50 |
| Número de saídas por mês | Numerador: contagem de saidas de AIH ( todos os motivos) Denominador: número de meses considerados * Hospitais considerados: 13 hospitais do Programa | Saídas / mês | 8.361,00 | 9.200,00 |
| Número de conformidades de infraestrutura hospitalar | Numerador: Número de hospitais com infraestrutura conforme Denominador: Número de hospitais atendidos por reforma pelo programa (13 hospitais) | percentual | 0,00 | 100,00 |
| Profissionais capacitados | Número de profissionais capacitados no Programa Avança Saúde II | número de profissionais | 0,00 | 1.300,00 |
| Modelagem de PPP Hospitalar entregues | Número de modelagem de PPP Hospitalar entregues | Relatorios | 0,00 | 3,00 |
| satisfação dos usuários aos serviços prestados nos hospitais. | Numerador: soma das notas atribuidas pelos usuários de 0-10 Denominador: número de respostas * Hospitais considerados: 13 hospitais do Programa | nota | 0,00 | 7,00 |

**2.7. Projeto/Componentes**

| Componentes | Valor(US$) |
|---|---|
| **C - COMPONENTE 1: REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR** | **299.280.000,00** |
| P - 1.1 Requalificação dos Hospitais | 214.000.000,00 |
| P - 1.2 Parceria Público Privada para requalificação dos Hospitais | 60.000.000,00 |
| P - 1.3 Hospitais equipados e mobiliados | 19.280.000,00 |
| P - 1.4 Apoio técnico à realização das obras | 6.000.000,00 |
| **C - COMPONENTE 2: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E INOVAÇÃO** | **102.820.000,00** |
| P - 2.1 Modelagem da PPP na Atenção Hospitalar | 3.000.000,00 |
| P - 2.2 Sistema de Logística Intra-Hospitalar | 98.220.000,00 |
| P - 2.3 Certificação da Qualidade | 800.000,00 |
| P - 2.4 Apoio à certificação de qualidade hospitalar | 600.000,00 |
| P - 2.5 Capacitação | 200.000,00 |
| **C - COMPONENTE 3: ADMINISTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA** | **8.500.000,00** |
| P - 3.1 Apoio ao Gerenciamento | 6.000.000,00 |
| P - 3.2 Consultoria para Coordenação Setorial do Programa | 1.600.000,00 |
| P - 3.3 Consultoria de Comunicação | 300.000,00 |
| P - 3.4 Avaliação do Programa | 600.000,00 |
| **Total dos Componentes** | **410.600.000,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

**Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:**

**C - COMPONENTE 1: REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR**

Este componente tem por objetivo requalificar e ampliar as redes hospitalar do Município de São Paulo. Serão financiados, entre outros: projetos, obras civis, apoio a fiscalização das obras, equipamentos médicos e mobiliário.

**P - 1.1 Requalificação dos Hospitais**

Requalificação dos hospitais por meio de reformas de recuperação da estrutura civil, reforma de adequação às novas normativas sanitárias e acessibilidade e incêndio.
Está dividido em dois grupos de hospitais, o primeiro grupo são os 5 hospitais com projeto básico em revisão para licitação que usarão recurso de contrapartida (estimado $ 78.500.000) e os demais 5 hospitais com projeto contratados pelo programa (estimado $ 135.500.000).

**P - 1.2 Parceria Público Privada para requalificação dos Hospitais**

Requalificação de hospitais por meio de Parceria Público Privada que possibilitará ofertar à população hospitais modernizados e focados no atendimento ao paciente.
Serão três hospitais que serão objeto de PPP e no programa estima-se recurso de parte do CAPEX do(s) concessionário(s) no valor de $60.000.000.

**P - 1.3 Hospitais equipados e mobiliados**

Compra de novos equipamentos médicos e mobiliários para os 10 hospitais reformados ($19.280.000).

**P - 1.4 Apoio técnico à realização das obras**

Apoio técnico à realização das obras incluindo elaboração de projetos e apoio a fiscalização das obras ($6.000.000).

**C - COMPONENTE 2: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E INOVAÇÃO**

Este componente aumentará o desempenho da Rede Hospitalar da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) mediante a ampliação de suas capacidades institucionais, estratégicas e gerenciais.

**P - 2.1 Modelagem da PPP na Atenção Hospitalar**

Modelagem para concessão por meio de PPP, contemplando avaliação da estrutura (engenharia), demandas e processos assistenciais, modelagem econômico-financeira e modelagem jurídica ($3.000.000).

**P - 2.2 Sistema de Logística Intra-Hospitalar**

Implantação de sistema para informatizar a logística intra-hospitalar nos hospitais com administração direta da SMS-SP ($ 98.220. 000)

**P - 2.3 Certificação da Qualidade**

Certificação de qualidade nos 24 hospitais municipais e 6 laboratórios. ($ 800.000).
As Instituições deverão demostrar que os seus processos atendem aos requisitos da instituição acreditadora para receber um Selo/ Certificado de qualidade.

**P - 2.4 Apoio à certificação de qualidade hospitalar**

Consultoria para apoio a certificação de qualidade em hospitais e laboratórios incluindo diagnóstico situacional, proposição de melhoria nos processos, acompanhamento da implementação dos novos processos e apoio às visitas de certificação. ($600.000)

**P - 2.5 Capacitação**

Capacitação de profissionais da rede hospitalar e laboratorial da SMS-SP para operacionalização do sistema de suprimentos intra-hospitalar e implantação dos processos de qualidade ($ 200.000)

**C - COMPONENTE 3: ADMINISTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA**
Este componente apoiará a SMS a executar o Projeto e dar andamento aos resultados previstos. Serão financiados, entre outros: (i ) serviços de apoio à gestão do Projeto; (ii) serviços técnicos especializados; (iii) auditoria independente; e (iv) avaliações intermediárias, final e de impacto do Projeto.

**P - 3.1 Apoio ao Gerenciamento**
Consultoria de apoio ao gerenciamento do Programa Avança Saúde II incluindo apoio técnico (engenharia e sistemas), aquisições, financeiro e jurídico. ($ 6.000.000)

**P - 3.2 Consultoria para Coordenação Setorial do Programa**
Consultores individuais para atuarem como coordenadores setoriais, em suas áreas de especialidade, em apoio ao coordenador geral do Programa. ($ 1.600.000)

**P - 3.3 Consultoria de Comunicação**
Consultorias para apoiar a comunicação e divulgação do programa: apresentações, press release, site institucional e livro síntese do Programa. ($300.000)

**P - 3.4 Avaliação do Programa**
Consultorias para avaliação do Programa exigidas pelo agente financiador: Auditoria financeira, Análise de Impacto e Avaliação Intermediaria e Final. ($ 600.000)

| Categoria de Gasto | Unidade de medida | Meta | Valor | % Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| **Obras** | - | - | **214.000.000,00** | **52,12** |
| P- 1.1 Requalificação dos Hospitais | Número de hospitais | 10,00 | 214.000.000,00 | 52,12 |
| **Bens** | - | - | **79.280.000,00** | **19,31** |
| P- 1.2 Parceria Público Privada para requalificação dos Hospitais | Número de hospitais | 3,00 | 60.000.000,00 | 14,61 |
| P- 1.3 Hospitais equipados e mobiliados | Número de hospitais | 10,00 | 19.280.000,00 | 4,70 |
| **Consultoria** | - | - | **18.100.000,00** | **4,41** |
| P- 1.4 Apoio técnico à realização das obras | Relatórios | 48,00 | 6.000.000,00 | 1,46 |
| P- 2.1 Modelagem da PPP na Atenção Hospitalar | No.hospitais modelados | 3,00 | 3.000.000,00 | 0,73 |
| P- 2.4 Apoio à certificação de qualidade hospitalar | Equip. saúde proc. aprim. | 30,00 | 600.000,00 | 0,15 |
| P- 3.1 Apoio ao Gerenciamento | Relatórios | 48,00 | 6.000.000,00 | 1,46 |
| P- 3.2 Consultoria para Coordenação Setorial do Programa | Relatórios | 48,00 | 1.600.000,00 | 0,39 |
| P- 3.3 Consultoria de Comunicação | Relatórios | 48,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| P- 3.4 Avaliação do Programa | Relatórios | 8,00 | 600.000,00 | 0,15 |
| **Serviços que Não de Consultoria** | - | - | **99.020.000,00** | **24,12** |
| P- 2.2 Sistema de Logística Intra-Hospitalar | No Hospitais sistema impl | 13,00 | 98.220.000,00 | 23,92 |
| P- 2.3 Certificação da Qualidade | Equip. saúde certificados | 30,00 | 800.000,00 | 0,19 |
| **Capacitação e Treinamento** | - | - | **200.000,00** | **0,05** |
| P- 2.5 Capacitação | Profissionais capacitados | 300,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| **Total Geral** | - | - | **410.600.000,00** | **100,00** |

**2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS**
Dentre as etapas já realizadas e que possibilitam a qualificação e consolidação de um projeto que atua sobre os principais problemas de inovação tecnológica e acesso a serviços e exames especializados na saúde, ressaltamos que:

Em junho de 2019 foi firmado o Contrato de Empréstimo entre o município de São Paulo e o BID para o Programa Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais da Cidade de São Paulo ? Avança Saúde SP, com objetivo de melhorar acesso e qualidade dos serviços, tendo como foco a atenção primária e a rede de urgência e emergência, bem como o fortalecimento da gestão da informação com incentivo à inovação e uso de novas tecnologias em saúde. Com relação as obras e reformas previstas no Avança Saúde São Paulo I , temos 13 UPAs (8 obras novas e 5 reformas), 99 UBSs (11 obras novas e 88 reformas), 01 Centro de Cuidados Integrados reformado, além dos Hospitais de Brasilândia e dos equipamentos para o Hospital Parelheiros, e a reforma do Pronto Socorro do Hospital São Paulo. Já foram entregues para a sociedade: 06 UPAs novas e 2 reformas; 01 UBS nova e 84 reformas; todos os hospitais e pronto socorro em funcionamento.

No âmbito da saúde digital o Avança Saúde SP I, inovou ao desenvolver as bases para a implantação da telemedicina, do prontuário eletrônico e a integração dos dados clínicos. O e-saudesp, uma das entregas, funciona como plataforma de saúde disponível nas versões Web, Android e iOS. A Teletriagem @covid, foi essencial durante a pandemia, um canal de acolhimento aos pacientes com dúvidas ou sintomas da Covid-19, conforme o resultado, o paciente poderá ter acesso a teleconsulta com médicos e enfermeiros. O e-saudesp já registrou 15 milhões de acesso e mais de 1,5 milhões de atendimentos (https://www.capital.sp.gov.br/noticia/aplicativo-e-saudesp-oferece-informacoes-sobre-a-vacinacao-anticovid-na-capital). O também foi destaque em evento realizado na Suíça (https://www.capital.sp.gov.br/noticia/aplicativo-e-saudesp-e-destaque-em-evento-na-suica#:~:text=O%20aplicativo%20e%2DsaúdeSP%2C%20da,cidade%20de%20Basiléia%2C%20na%20Suíça).

A implantação do sistema de suprimentos, possibilitará que a SMS aprimorar o controle da logística de medicamentos e insumos ao integrar informações sobre o estoque central e com os estoques locais (aproximadamente mil unidades de saúde).

Ainda no âmbito da tecnologia da informação em saúde outra entrega concluída foi o Gerenciamento Integrado de Classificação de Risco e Articulação da Rede, com 53 portas/serviços integradas gerando informações sobre tipo de atendimento e classificação de risco, bem como informações gerenciais sobre as unidades. Foram treinados 1.486 profissionais no protocolo Manchester.

Previsto para iniciar, ainda em 2023, o Selo de Qualidade ONA irá acreditar 340 UBS e contribuir para estruturar o Núcleo de Gestão da Qualidade na SMS-SP. Um passo importantíssimo para alcance da efetividade e qualidade da assistência, um dos compromissos da gestão municipal.

Outra grande inovação do Programa, que visa dar transparência e levar conhecimento para a população sobre as obras em andamento é o Sistema ObraGov (https://smssp.obrasgov.com.br/obras-gov-map/#/map). De forma simples e rápida, através de uma ferramenta de georeferenciamento é possível acessar informações detalhadas sobre as obras como período de execução, empresa contratada, prazos de execução, informações financeiras, identificação dos fiscais da obra, fotos.

Recentemente o Programa Avança Saúde SP I passou pela avaliação intermediária (anexo 9), recebendo classificação Satisfatória em todos os critérios analisados pelo BID em termos de relevância, eficácia e eficiência. Com boa execução física e financeira, considerando o período de inicio do Programa e a pandemia COVID-19, é visível que os indicadores de resultados estão caminhando na direção adequada, o que mostra o intento da equipe da UCP na execução do Programa.

Por fim, vale destacar o reconhecimento e resultados alcançados no Avança Saúde SP I, em especial o reconhecimento da população como demonstrado na Pesquisa realizada pelo Datafolha, que aponta que a rede municipal de saúde é um dos serviços mais bem avaliados pelos paulistanos; o resultado enalteceu os avanços na informatização da rede com foco na promoção de cuidado na Atenção Básica (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=346403#:~:text=O%20Sistema%20Único%20de%20Saúde, Paulo). Outros prêmios e reconhecimentos podem ser consultados: https://www.capital.sp.gov.br/noticia/aplicativo-e-saudesp-e-destaque-em-evento-na-suica#:~:text=O%20aplicativo%20e%2Dsa%C3%BAdeSP%2C%20da,cidade%20de%20Basil%C3%A9ia%2C%20na%20Su%C3%AD%C3%A7a.

Apesar dos avanços alcançados com o Programa Avança Saúde SP I, que ajudou o município no enfrentamento da pandemia, há no momento o desafio de fortalecer e qualificar os serviços hospitalares que enfrentam desafios, estruturais e de qualificação, para atender a demanda reprimida, situação agravada no pós-pandemia.

Assim sendo, é importante dar continuidade as ações do Avança Saúde I, para prosseguir nas mudanças necessárias que levem à conformação de um sistema integrado que opere de forma contínua e proativa e que seja capaz de responder, com eficiência, efetividade, qualidade e de modo equilibrado, às condições agudas e crônicas da população. Adequado para a atual situação epidemiológica e demográfica do município de São Paulo. Ou seja, o Avança Saúde II, que aprimorará a rede hospitalar, representa continuidade das ações do programa anterior que teve foco na Atenção Básica.

Das lições aprendidas que a prefeitura poderá levar para o próximo programa destacamos:

1) Uma readequação de procedimento ocorrida no Avança Saúde I foi estruturar a área de engenharia na Secretaria de Saúde, desenvolvendo capacidade para realizar contratações e acompanhar obras independente da SIURB (secretaria de obras). Entre outros aprendizados, podemos citar a utilização do sistema de gestão de obras contratado inicialmente para o Avança Saúde que passou a ser utilizado para todas as obras da SMS. Desta forma, a Secretaria encontra-se apta para realizar as obras previstas no Avança Saúde II.

2) Outro ganho desenvolvido neste período de grande implantação de obras, foi a capacidade das unidades da SMS se adequarem para realizar reformas em Unidades que permaneceram atendendo ao público. Destaca-se que esse desafio no Avança Saúde I foi intensificado por conta da COVID.

3) Necessidade de complementar e potencializar os benefícios da gestão da logística (sistema implantado no Avança Saúde I) ao fluxo interno de suprimentos nos hospitais, garantindo a sinergia entre os dois processos. O aprendizado dos técnicos da SMS, tanto no processo de concepção do sistema, contratação e implantação, aumentará a chance de sucesso e eficiência da contratação do próximo sistema que é bastante mais complexo que o anterior.

4) No processo de certificação de qualidade iniciado no Avança Saúde I, foi percebida a necessidade de envolvimento de diversas áreas técnicas da SMS e não apenas da equipe específica da unidade a ser certificada. Houve melhoria no processo de comunicação entre equipe centralizada com a equipe da ponta, que efetivamente atende ao paciente. Desta forma, a Secretaria, neste momento, está mais apta a expandir a certificação para a rede hospitalar.

5) Uma lição apendida no Avança Saúde é considerar folga no prazo de execução para acomodar desvios resultantes de grande quantidade de interferências, fatos supervenientes e obras de reformas de prédios antigos e unidades de saúde que mantém o atendimento ao usuário.

6) Por fim, cabe destacar o aprendizado da SMS para realização de projeto com financiamento internacional, que possui regras de contratação específica, processos de prestação de contas etc. Esse aprendizado torna-se mais aplicável quando mantido o mesmo agente financiador.

Vale destacar que para o Avança Saúde SP II não há necessidade de licenciamento ambiental tendo em vistas as intervenções ocorrerão em áreas já ocupadas pelos hospitais e já foram realizados 5 projetos de engenharia que estão em processo de revisão para abertura de licitação em 2023.

**2.9. Projeto/Abrangência Geográfica**

**Abrangência Geográfica:** Municipal

| |
|---|
| MUNICIPIO DE SAO PAULO(SP) |

**2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO**

CONDIÇÕES FINANCEIRAS

Devido às necessidades e desafios de saúde pública aqui apresentadas pelo município de São Paulo, a possibilidade financiamento externo pode permitir a manutenção e ampliação do acesso à saúde de qualidade, oferecendo inovação para o setor público.

Por outro lado, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) tem tradição em oferecer oportunidades de financiamento para países da América Latina e Caribe para melhoria da atenção à saúde das populações, o município de São Paulo oferece este pleito, como uma estratégia para a continuidade da melhoria do SUS no município.

O valor proposto do empréstimo é de $ 205.300.00,00 com contrapartida do município de $ 205.300.00,00

Este projeto seguirá os Termos e Condições Financeiras Aplicáveis aos Empréstimos de Investimento com Recursos do Capital Ordinário do BID (vide anexo), sendo:

-Carência: 5,5 anos (66 meses)

-Prazo de amortização: 234 meses em parcelas semestrais

-Vida Média Ponderada (VMP): 15,25 anos (máximo)

Período para amortização e Vida Média Ponderada (VMP): O vencimento de empréstimos de investimento é de no máximo 25 anos e a vida média ponderada máxima de no máximo 15,25 anos.

Períodos de Desembolso e Carência: Os empréstimos standard têm um cronograma de amortização linear, com prestações semestrais ( ou trimestrais), consecutivas e na medida do possível iguais. Considerando que o período para desembolsos típico é de 5 anos contados da data de vigência do contrato de empréstimo, o período de carência típico é de 66 meses.

Taxas de juros: SOFR + 1,16% a.a. (2o trimestre 2023)

Credit Fee: até 0,75% sobre o saldo não desembolsado

Recursos para inspeção e supervisão de até 1% do valor do empréstimo, cobrado semestralmente durante o prazo original de

desembolsos, dividido pelo número de semestres compreendidos no prazo original de desembolsos

Moeda de referência: A moeda na qual se pretende contratar o empréstimo ora pretendido é o dólar americano, considerando a cotação do câmbio de fechamento de venda, em 24/04/2023, de R$/US$ 5,05 ($ 1,00=R$ 5,05), conforme informação do BACEN.

Obs: Os valores das taxas de juros do BID são de referência, podendo variar conforme o período.

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO

A decisão de buscar financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) decorre principalmente do reconhecimento da expertise do Banco em financiar grandes projetos com finalidades similares, tanto no Brasil quanto nos demais países membros. Na atualidade, o BID é a principal fonte de financiamento multilateral para o desenvolvimento econômico, social e institucional da América Latina e do Caribe, e para a integração regional. Na área de políticas integradas de saúde, o BID financia atualmente a execução de 50 projetos em toda América Latina e Caribe.

Além disso, o Governo paulistano compartilha do entendimento do BID de que as ações de cooperação técnica, consultoria, financiamentos, assistência técnica e pesquisas devem ser realizadas de forma sustentável. Considera, ainda, que essas ações estão relacionadas a um amplo leque de possibilidades que, se integradas, potencializam o alcance dos objetivos propostos. Portanto, o valor agregado pelo Banco, além da contribuição financeira, em todas as fases dos programas ou projetos, inclui também ênfase nas ações de sustentabilidade institucional. O fortalecimento da qualidade da Gestão constitui, certamente, um dos objetos de preocupação e estratégias do BID, o que reforça a escolha da fonte externa de financiamento pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Somado a isso, comparativamente ao mercado interno, as condições oferecidas pelo BID mostram-se atrativas, especialmente quanto às taxas de juros.

Em estudo elaborado pela Secretaria Municipal da Fazenda, em julho de 2023, considerando as características do projeto, foi constatado que o BID possui as melhores condições financeiras entre as instituições de maior renome e tradição no mercado, conforme comparativo abaixo:

1.BID: CET 6,36% a.a. (SOFR + 1,16% + 0,75% a.a. sobre o saldo não desembolsado)

2.BIRD: CET 6,53% a.a. (SOFR + 1,34% + 0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado+0,25% sobre o valor contratado)

3.CAF: CET 7,27% a.a. (SOFR + 2% + 0,35% a.a. sobre o saldo não desembolsado + 0,85% sobre o valor contratado)

4.Operação de crédito interno: CET 16,26% a.a. (111,04% do CDI + 2% sobre o valor contratado)

*obs: foram consideradas as taxas de juros atuais de SOFR e CDI

**2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO**

AREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO:

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

Em termos de sustentabilidade vale destacar que a requalificação dos hospitais, irá promover eficiência energética, redução de custos e sustentabilidades para os hospitais beneficiados. Em consonância com o Manual de Sustentabilidade para Edificações Públicas, da Secretaria Municipal de Serviços e Obras do Município de São Paulo (Anexo 05) que define as diretrizes e os parâmetros sustentáveis.

Este item será atendido pelo componente 1 nos produtos de "Requalificação dos Hospitais" e "Parceria Público Privada para requalificação dos Hospitais".

1.2 eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

Na requalificação dos hospitais, além do destacado no item 1.1 quanto a eficiência energética, serão instalados painéis fotovoltaicos promovendo geração e uso de energia de fontes renováveis.

Este item será atendido pelo componente 1 nos produtos de "Requalificação dos Hospitais" e "Parceria Público Privada para requalificação dos Hospitais".

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico.

Na requalificação dos hospitais será promovido tratamento de esgoto e coleta diferenciada dos resíduos hospitalares como proteção do meio ambiente.

Este item será atendido pelo componente 1 nos produtos de "Requalificação dos Hospitais" e "Parceria Público Privada para requalificação dos Hospitais".

1.8 Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis

O programa prevê investimentos em construção civil que é um setor emprega população de baixa renda.

1.9. Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis

O objetivo do Programa é contribuir para a melhorar as condições de saúde da população do Município de São Paulo, por meio da ampliação do acesso, da qualidade dos serviços ofertados, da garantia de segurança do paciente e da melhoria do desempenho dos processos da rede hospitalar municipal as populações de baixa renda e vulneráveis são as mais carentes de atendimento de Saúde, portanto, as intervenções propostas, ao melhorarem/ampliarem a oferta dos serviços hospitalares, irão atender majoritariamente este Público.

Este item será atendido pelo componente 1 nos produtos de "Requalificação dos Hospitais" e "Parceria Público Privada para requalificação dos Hospitais" e componente 2 "aprimoramento dos processos e inovação?.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários

O programa promove a ampliação do atendimento hospitalar público que beneficiará a população de São Paulo, majoritariamente as populações mais carentes.

Atualmente as cirurgias de urgência tomam espaço das cirurgias eletivas e com a restruturação proposta haverá maior oferta de cirurgias eletivas propiciando diminuição do tempo de espera para cirurgias eletivas, assim como, a aumento da oferta de procedimentos cirúrgicos voltados para população trans.

Este item será atendido pelo componente 1 nos produtos de ?Requalificação dos Hospitais? e ?Parceria Público Privada para requalificação dos Hospitais e componente 2 ?aprimoramento dos processos e inovação?.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça

O programa promove a ampliação do atendimento hospitalar público que beneficiará prioritariamente as populações mais carentes, em todas faixas etárias, independente de gênero e raça

Este item será atendido pelo componente 1 nos produtos de ?Requalificação dos Hospitais? e ?Parceria Público Privada para requalificação dos Hospitais e componente 2 ?aprimoramento dos processos e inovação?.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadão

A certificação de qualidade implicará em melhoria da prestação/processos dos serviços ofertados nos Hospitais, garantindo maior segurança para pacientes e profissionais de saúde tornando os processos de trabalho mais eficientes com melhor integração entre setores . Além dessa ação, cabe mencionar a implantação de sistema informatizado e inovador que proporcionará uma melhoria no processo de gestão de suprimentos intra-hospitalar assegurando maior controle, redução de custos e fluidez em todas as fases do processo, desde aquisição até o usuário final.

Este item será atendido pelo componente 2 no Produto ?sistema de logística intra-hospitalar? e ?Certificação da Qualidade?.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde

Todas as ações do programa visam a melhoria das condições de Saúde da População por meio do aprimoramento do atendimento Hospitalar:

- Requalificação/reforma dos hospitais;

- Atualização do parque tecnológico, no tocante a equipamentos assistenciais e de apoio diagnóstico;

- Certificação de qualidade dos hospitais e dos laboratórios municipais;

- Sistema informatizado de logística intra-hospitalar e

- Capacitação de profissionais da Saúde da Rede Hospitalar Municipal.

Este item será atendido pelo componente 1 nos produtos de "Requalificação dos Hospitais" e "Parceria Público Privada para requalificação dos Hospitais e componente 2 "aprimoramento dos processos e inovação"

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

O sistema informatizado de gestão de suprimentos intra-hospitalar deverá gerar padronização e ganho de eficiência no fluxo de distribuição de insumos no hospital, redução de custos e aumento da segurança do paciente, inovando o processo de prescrição, dispensação e administração de Medicamentos.

Este item será atendido pelo componente 2 no Produto "sistema de logística intra-hospitalar" e "Certificação da Qualidade".

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada

Está prevista no Programa a realização de PPP para a requalificação de três Hospitais.

Este item será atendido pelo componente 1 no produto de "Parceria Público Privada para requalificação dos Hospitais" e componente 2 no produto "Modelagem da PPP na Atenção Hospitalar"

BENEFICIÁRIOS

Os beneficiários últimos das ações propostas nesta Carta Consulta são todos os cidadãos do município de São Paulo, ou seja, mais de 12 milhões de habitantes.

Além dos munícipes paulistanos, São Paulo é referencia para outros 39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo constituindo a quarta maior aglomeração urbana do mundo, com população de mais de 21 milhões de habitantes, além dos pacientes de outros Estados da Federação que na dificuldade de acesso, buscam alternativas na capital paulista.

Importante destacar que a cidade de São Paulo é pioneira ao instituir, através da lei municipal a "Política Municipal para a População Imigrante, a qual garante ao imigrante o pleno acesso a direitos sociais e serviços públicos "independentemente de sua situação imigratória e documental", não fazendo distinção entre brasileiros e imigrantes, assim como prevê̂ a promoção da transparência sobre os dados de atendimento à essa população. Segundo dados da Prefeitura de São Paulo, mais de 360 mil imigrantes vivem legalmente no município.

**2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO**

Sim

## 3. Financiamento

**3.1. Financiamento/Fonte**

**Moeda de Referência:** Dólar

| Fontes Internas | Sigla | Moeda | Valor Proposto | Taxa de Câmbio | Valor de Referência US $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida Financeira | CF | US$ | 205.300.000,00 | 1,00 | 205.300.000,00 |
| **Fontes Externas** | **Sigla** | **Moeda** | **Valor Proposto** | **Taxa de Câmbio** | **Valor de Referência US $** |
| Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID | BID | US$ | 205.300.000,00 | 1,00 | 205.300.000,00 |
| Total: | | | 410.600.000,00 | | 410.600.000,00 |

**3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS**

Concordo

## 4. Execução

**4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL**

ARRANJO INSTITUCIONAL

O projeto será realizado pelo Município de São Paul, através de sua Secretaria Municipal da Saúde (SMS-SP).

A secretaria formalizará, uma Unidade de Gestão do Projeto (UGP), que servirá como órgão de ligação entre a SMS-SP, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e outras organizações participantes.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE (Anexo 6)

A Prefeitura Municipal de São Paulo é responsável por aprovar as ações do Programa Avança Saúde II.

A Secretaria Municipal de Saúde é responsável pela elaboração da Carta Consulta e preparação do Programa; execução das ações dos componentes 1, 2 e 3 e gestão financeira do Projeto.

Unidade de Gestão do Programa (UGP), ligada diretamente ao Gabinete do Secretário da SMS é unidade responsável pelas ações dos componentes 1, 2 e 3 e gestão financeira do Projeto.

A Secretaria executiva de Atenção Hospitalar, subordinada ao Gabinete do Secretario da SMS, é responsável por prestar informações sobre as ações do Componente1 e 2 e será informada sobre as ações do componente 3.

A Secretaria Executiva Gestão Administrativa, subordinada ao Gabinete do Secretário da SMS, é responsável por prestar informações sobre as ações do Componente1,2 e 3 e gestão financeira do Projeto.

Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID será informada sobre as ações do componente 1,2 e 3 e gestão financeira do Projeto.

ARRANJO OPERACIONAL

O arranjo operacional deste programa contará com a equipe da SMS-SP com experiência prévia na execução de projetos com organismos internacionais, como foi o caso recente do Avança Saúde I.

Dada a experiência bem sucedida do Avança Saúde I (financiado pelo BID), o arranjo Operacional será constituído com a mesma estrutura que funciona atualmente:

Unidade de Gestão do Programa é responsável pela execução do Programa (aquisições, acompanhamento das ações, prestação de contas, elaboração dos projetos e fiscalização das obras). Para tanto a UGP contará, além dos servidores Públicos da SMS, com as seguintes consultorias de Apoio: Gerenciamento, Fiscalização de Obras, consultores individuais para áreas específicas.

O órgão executor, portanto, possui conhecimento sobre as políticas de aquisição e salvaguardas do BID. Este conhecimento foi adquirido no Projeto Avança Saúde I.

Destacamos demais órgãos com experiencia em Financiamentos BID que poderão participar da execução do Programa

?Área Jurídica da SMS;

?Área finanças e orçamento SMS;

?Área de Contratos Administrativos da SMS

?Secretaria Municipal da Fazenda

**4.2. Execução/Executores**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Executor: | Secretaria Municipal da Saúde - Prefeitura do Município de São Paulo | | |
| Representante Oficial: | Luiz Carlos Zamarco | | |
| Endereço da Sede: | Rua General Jardim, 36 - República | | |
| E-mail Institucional: | | | |
| Telefone: | 2027-2005 | Fax: | |
| CNPJ: | 13864377000130 | UF: | |

**4.3. Execução/Prazo**

**Prazo de Desembolso:** 5 **Anos**

**4.4. Execução/Cronograma**

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 1 FONTES CF | Ano 1 FONTES BID | TOTAL CF | TOTAL BID |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - COMPONENTE 1: REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR** | **299.280.000,00** | **20.000.000,00** | **20.500.000,00** | | |
| P - 1.1 Requalificação dos Hospitais | 214.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | | |
| P - 1.2 Parceria Público Privada para requalificação dos Hospitais | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - 1.3 Hospitais equipados e mobiliados | 19.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - 1.4 Apoio técnico à realização das obras | 6.000.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - COMPONENTE 2: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E INOVAÇÃO** | **102.820.000,00** | **0,00** | **2.220.000,00** | | |
| P - 2.1 Modelagem da PPP na Atenção Hospitalar | 3.000.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | |
| P - 2.2 Sistema de Logística Intra-Hospitalar | 98.220.000,00 | 0,00 | 1.720.000,00 | | |
| P - 2.3 Certificação da Qualidade | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - 2.4 Apoio à certificação de qualidade hospitalar | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - 2.5 Capacitação | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - COMPONENTE 3: ADMINISTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA** | **8.500.000,00** | **0,00** | **560.000,00** | | |
| P - 3.1 Apoio ao Gerenciamento | 6.000.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | | |
| P - 3.2 Consultoria para Coordenação Setorial do Programa | 1.600.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | | |
| P - 3.3 Consultoria de Comunicação | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - 3.4 Avaliação do Programa | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **20.000.000,00** | **23.280.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| | | Ano 2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR | FONTES | | TOTAL | TOTAL |
| COMPONENTES | CUSTO | CF | BID | CF | BID |
| **C - COMPONENTE 1: REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR** | | **29.575.000,00** | **31.500.000,00** | | |
| P - 1.1 Requalificação dos Hospitais | | 27.295.000,00 | 30.000.000,00 | | |
| P - 1.2 Parceria Público Privada para requalificação dos Hospitais | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - 1.3 Hospitais equipados e mobiliados | | 2.280.000,00 | 0,00 | | |
| P - 1.4 Apoio técnico à realização das obras | | 0,00 | 1.500.000,00 | | |
| **C - COMPONENTE 2: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E INOVAÇÃO** | | **10.100.000,00** | **11.600.000,00** | | |
| P - 2.1 Modelagem da PPP na Atenção Hospitalar | | 0,00 | 1.500.000,00 | | |
| P - 2.2 Sistema de Logística Intra-Hospitalar | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | |
| P - 2.3 Certificação da Qualidade | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - 2.4 Apoio à certificação de qualidade hospitalar | | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| P - 2.5 Capacitação | | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - COMPONENTE 3: ADMINISTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA** | | **325.000,00** | **1.565.000,00** | | |
| P - 3.1 Apoio ao Gerenciamento | | 0,00 | 1.400.000,00 | | |
| P - 3.2 Consultoria para Coordenação Setorial do Programa | | 260.000,00 | 100.000,00 | | |
| P - 3.3 Consultoria de Comunicação | | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| P - 3.4 Avaliação do Programa | | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **40.000.000,00** | **44.665.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| | | Ano 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR | FONTES | | TOTAL | TOTAL |
| COMPONENTES | CUSTO | CF | BID | CF | BID |
| **C - COMPONENTE 1: REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR** | | **39.510.000,00** | **37.000.000,00** | | |
| P - 1.1 Requalificação dos Hospitais | | 31.205.000,00 | 35.000.000,00 | | |
| P - 1.2 Parceria Público Privada para requalificação dos Hospitais | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - 1.3 Hospitais equipados e mobiliados | | 8.305.000,00 | 0,00 | | |
| P - 1.4 Apoio técnico à realização das obras | | 0,00 | 2.000.000,00 | | |
| **C - COMPONENTE 2: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E INOVAÇÃO** | | **10.195.000,00** | **16.695.000,00** | | |
| P - 2.1 Modelagem da PPP na Atenção Hospitalar | | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| P - 2.2 Sistema de Logística Intra-Hospitalar | | 10.000.000,00 | 15.500.000,00 | | |
| P - 2.3 Certificação da Qualidade | | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| P - 2.4 Apoio à certificação de qualidade hospitalar | | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| P - 2.5 Capacitação | | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| **C - COMPONENTE 3: ADMINISTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA** | | **295.000,00** | **1.695.000,00** | | |
| P - 3.1 Apoio ao Gerenciamento | | 0,00 | 1.400.000,00 | | |
| P - 3.2 Consultoria para Coordenação Setorial do Programa | | 180.000,00 | 180.000,00 | | |
| P - 3.3 Consultoria de Comunicação | | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| P - 3.4 Avaliação do Programa | | 90.000,00 | 90.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **50.000.000,00** | **55.390.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| | | Ano 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR | FONTES | | TOTAL | TOTAL |
| COMPONENTES | CUSTO | CF | BID | CF | BID |
| **C - COMPONENTE 1: REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR** | | **39.485.000,00** | **31.500.000,00** | | |
| P - 1.1 Requalificação dos Hospitais | | 0,00 | 30.000.000,00 | | |
| P - 1.2 Parceria Público Privada para requalificação dos Hospitais | | 37.000.000,00 | 0,00 | | |
| P - 1.3 Hospitais equipados e mobiliados | | 2.485.000,00 | 0,00 | | |
| P - 1.4 Apoio técnico à realização das obras | | 0,00 | 1.500.000,00 | | |
| **C - COMPONENTE 2: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E INOVAÇÃO** | | **10.270.000,00** | **15.770.000,00** | | |
| P - 2.1 Modelagem da PPP na Atenção Hospitalar | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - 2.2 Sistema de Logística Intra-Hospitalar | | 10.000.000,00 | 15.500.000,00 | | |
| P - 2.3 Certificação da Qualidade | | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| P - 2.4 Apoio à certificação de qualidade hospitalar | | 70.000,00 | 70.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P - 2.5 Capacitação | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| **C - COMPONENTE 3: ADMINISTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA** | | **245.000,00** | **1.645.000,00** | | |
| P - 3.1 Apoio ao Gerenciamento | | 0,00 | 1.400.000,00 | | |
| P - 3.2 Consultoria para Coordenação Setorial do Programa | | 180.000,00 | 180.000,00 | | |
| P - 3.3 Consultoria de Comunicação | | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| P - 3.4 Avaliação do Programa | | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **50.000.000,00** | **48.915.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 5 FONTES CF | Ano 5 FONTES BID | TOTAL CF | TOTAL BID |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - COMPONENTE 1: REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR** | | **29.210.000,00** | **21.000.000,00** | **157.780.000,00** | **141.500.000,00** |
| P - 1.1 Requalificação dos Hospitais | | 0,00 | 20.500.000,00 | 78.500.000,00 | 135.500.000,00 |
| P - 1.2 Parceria Público Privada para requalificação dos Hospitais | | 23.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 |
| P - 1.3 Hospitais equipados e mobiliados | | 6.210.000,00 | 0,00 | 19.280.000,00 | 0,00 |
| P - 1.4 Apoio técnico à realização das obras | | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| **C - COMPONENTE 2: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E INOVAÇÃO** | | **15.535.000,00** | **10.435.000,00** | **46.100.000,00** | **56.720.000,00** |
| P - 2.1 Modelagem da PPP na Atenção Hospitalar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| P - 2.2 Sistema de Logística Intra-Hospitalar | | 15.300.000,00 | 10.200.000,00 | 45.300.000,00 | 52.920.000,00 |
| P - 2.3 Certificação da Qualidade | | 150.000,00 | 150.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| P - 2.4 Apoio à certificação de qualidade hospitalar | | 60.000,00 | 60.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| P - 2.5 Capacitação | | 25.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **C - COMPONENTE 3: ADMINISTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA** | | **555.000,00** | **1.615.000,00** | **1.420.000,00** | **7.080.000,00** |
| P - 3.1 Apoio ao Gerenciamento | | 170.000,00 | 1.230.000,00 | 170.000,00 | 5.830.000,00 |
| P - 3.2 Consultoria para Coordenação Setorial do Programa | | 180.000,00 | 180.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| P - 3.3 Consultoria de Comunicação | | 75.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| P - 3.4 Avaliação do Programa | | 130.000,00 | 130.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **Total** | **410.600.000,00** | **45.300.000,00** | **33.050.000,00** | **205.300.000,00** | **205.300.000,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

## 5. Riscos

### 5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Não estão previstos riscos a atos legais dadas as caraterísticas do Programa (Reforma em terrenos próprios e implantação sistema).

### 5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Eleições Municipais de 2024 podem resultar em revisão das ações e alteração das prioridades do Programas.

Para mitigar este risco, as ações serão direcionadas para que o contrato de empréstimo esteja firmado e o inicio das ações do programa ocorram antes das eleições Municipais previstas para 2024.

### 5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Por se tratar de reformas em terrenos de posse da Prefeitura, para a realização deste Programa não estão previstas desapropriações ou indenizações.

### 5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

As obras do Programa são reformas em terrenos já ocupados por hospitais, portanto o impacto ambiental é mínimo em geral são remanejamentos e podas de árvores.

Os possíveis impactos ambientais decorrentes deste Programa, serão minimizados através de projetos, ações e mecanismos voltados para a proteção do meio ambiente e a mitigação de impactos ambientais que eventualmente ocorram durante as intervenções, em conformidade com as leis municipais e dos respectivos órgãos de controles.

### 5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Não existe um impacto social do Programa que possa interferir negativamente na saúde da população do município, muito menos em populações vulneráveis como populações indígenas, quilombolas, entre outras.

O impacto social é positivo, na medida que qualifica a oferta de atendimento mais próximo das pessoas, além de gerar, durante a implementação oportunidades de emprego e renda.

### 5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Para a realização deste Programa não serão necessários reassentamentos por se tratar de obras de reforma em terrenos da Prefeitura

### 5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN